

УДК:618.14+/.146-006.6-08--059

Чингисова Ж.К., Кайрбаев М.Р., Кукубасов Е.К.,  
Шалбаева Р.Ш., Досаханов Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

## Выживаемость больных раком тела и шейки матки при использовании неоадьювантной полихимиотерапии

*Аннотация. Работа основана на анализе выживаемости больных раком тела (РТМ) и шейки (РШМ) матки, получивших лечение с использованием неоадьювантной полихимиотерапии (НПХТ). НПХТ при РТМ увеличила как общую (86,9%), так и безрецидивную (70,0%) выживаемость больных против 80,2% и 56,2% соответственно при комбинированном лечении. При РШМ с НПХТ общая пятилетняя выживаемость составила 75,0%, безрецидивная 66,7%, тогда как после сочетанной лучевой терапии показатели были 64,0% и 46,6%, являющаяся основным и общепринятым методом лечения местнораспространенного РШМ.*

Рак тела матки (РТМ) относится к ведущей патологии в онкогинекологии экономически развитых стран. Так среднегодовой прирост стандартизованного показателя заболеваемости женщин РТМ в России составляет 3,1% [1]. Ежегодно в мире выявляется около 400000 первичных больных РШМ, из которых почти половина умирают в течение первого года в связи с поздним диагностированием заболевания [2]. В Республике Казахстан процент запущенных форм РШМ (III-IV стадии) остается высоким, составляя в 2007 году в среднем 27,5%, однако в отдельных регионах эта цифра достигает 50,6% [3]. Высокие показатели запущенности РШМ, а также рост заболеваемости среди женщин молодого возраста диктуют необходимость разработки новых и совершенствования уже существующих методов комбинированного и комплексного лечения. Стандартными методами лечения местнораспространенных форм РШМ считаются лучевая терапия, хирургический метод или их комбинация [4]. Однако более чем у 50% больных возникают рецидивы заболевания уже в первые 2 года после окончания лечения (Сидоренко Ю.С.). Изучение неблагоприятных исходов сочетанной лучевой терапии 371 больной с местнораспространенным РШМ показало, что генерализация процесса у 26,3% больных наступает в течение первого года от начала лечения. Короткий период между лечением и прогрессированием опухоли у этих больных свидетельствует о недостаточной эффективности местно-регионарной лучевой терапии и наличии микрометастазов опухоли, не диагностируемых на этапе обследования к моменту выбора лучевого лечения [5].

По данным литературы известно [1, 6], что подавляющее большинство случаев прогрессирования заболевания и смертности от рака эндометрия приходится на первые три года жизни после лечения [7]. Кроме того, результаты лечения при наблюдении больных раком тела матки в течение трех и пяти лет не показали существенных разли-

чий в показателях, поэтому трехлетний период считается основным показателем отдаленных результатов лечения больных раком эндометрия.

### Материал и методы

Клинический материал исследования составили больные раком тела (РТМ) и шейки матки (РШМ). По характеристике лечебного воздействия при раке тела матки выделены следующие 2 группы больных: в первую (основную) группу включено 35 больных умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, которым проведены неоадьювантные курсы полихимиотерапии по схеме: цисплатин 50 мг/м<sup>2</sup> + 5фторурацил 500-700 мг/м<sup>2</sup> + циклофосфан 500 мг/м<sup>2</sup>, в последующем выполнено оперативное вмешательство. В послеоперационном периоде проведена дистанционная лучевая терапия. Во вторую группу (контрольную) вошли 38 больных с умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, получившие комбинированное лечение в объеме хирургического лечения и послеоперационного курса дистанционной лучевой терапии.

При раке шейки матки проводилась системная неоадьювантная полихимиотерапия (НПХТ) у 27 больных с морфологически подтвержденным диагнозом. Химиопрепараты вводились в периферическую либо центральную вену после предварительной гипергидратации и премедикации по следующей схеме: цисплатин 75 мг/м<sup>2</sup> в 1 день, гемзар 800-1000 мг/м<sup>2</sup> в 1 и 8 дни. С повторением курсов каждые три недели.

Общее состояние было удовлетворительным у большинства пациентов и равнялось 0-1 по шкале ECOG.

Весь материал был внесен в компьютерную базу данных. Статистическая обработка материала проводилась методом общей и корреляционной статистики с использованием компьютерного статистического пакета программы SPSS for Windows (версия 15.0).

При определении выживаемости использован актуальный способ Life tables и метод Kaplan-Meier, влияние изучаемых параметров на показатели выживаемости изучено с помощью регрессионной модели пропорционального риска Кокса.

### Результаты исследований

При изучении выживаемости больных раком тела матки в исследовании анализируются как трехлетние, так и пятилетние исходы заболевания (таблица 1). При этом показатели пятилетней выживаемости рассчитывались

актуриальным методом.

Таблица 1 – Результаты лечения больных раком тела матки по видам лечения

| Виды лечения                         | Выживаемость (М±m)% |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                      | 3 года              | 5 лет     |
| Комплексное (основная группа)        | 88,4±2,1            | 86,9±2,3  |
| Комбинированное (контрольная группа) | 82,0±2,1*           | 80,2±2,2* |

Примечание - \* -  $p < 0,05$ , \*\* -  $p < 0,01$  статистическая достоверность между группами по сравнению с комплексным лечением

Как видно из таблицы, общая 3-летняя выживаемость для пациентов основной группы составила 88,4±2,1%. В группе больных РТМ, где больным проводили комбинированное лечение, показатель был 82,0±2,1%, при сочетано-лучевой терапии показатель составил 67,4±2,3%.

Отдаленные результаты 3х и 5-летней выживаемости больных раком эндометрия показали, что общая 5-летняя выживаемость у больных, получивших комплексное лечение, была на 6,7% и 21,8% выше, чем при комбинированной терапии соответственно.

В работе были оценены отдаленные результаты лечения в зависимости от возраста, стадии и гистологической дифференцировки опухоли (таблица 2). Обращают на себя внимание данные о влиянии этих факторов на выживаемость больных.

Таблица 2 – Отдаленные результаты лечения больных раком тела матки в зависимости от возраста, стадии и гистологической структуры (в%)

| группы исследования       |                  | выживаемость |           |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Репродуктивный возраст    | группы           | 3 года       | 5 лет     |
|                           | I- Основная      | 100          | 100       |
|                           | II - Контрольная | 100          | 100       |
| Пременопаузальный возраст | I- Основная      | 83,1±2,3     | 81,2±2,1* |
|                           | II - Контрольная | 77,2±2,5     | 75,4±2,2  |
| Менопаузальный возраст    | I- Основная      | 81,8±3,5*    | 77,4±3,2* |
|                           | II - Контрольная | 69,1±3,3     | 66,0±3,1* |

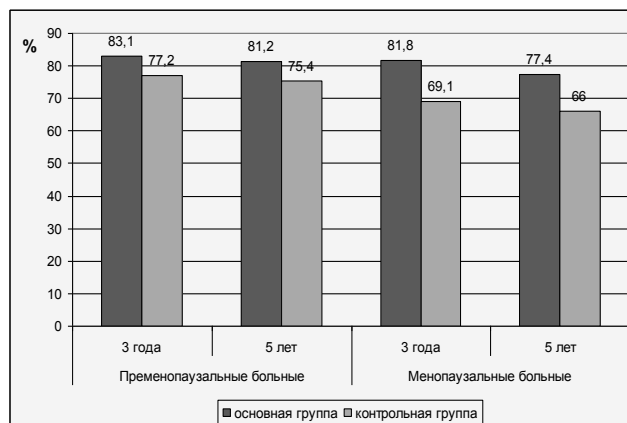


Рисунок 1 - Выживаемость больных РТМ в зависимости от возраста (пременопаузальные, менопаузальные больные) по видам лечения (%)

|                             |                  |           |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Первая стадия               | I- Основная      | 97,4±1,3  | 95,9±1,1  |
|                             | II – Контрольная | 95,6±1,4  | 93,8±1,2  |
| Вторая стадия               | I- Основная      | 91,3±3,1* | 89,8±3,1* |
|                             | II – Контрольная | 82,9±3,0  | 80,7±2,9  |
| Третья стадия               | I- Основная      | 75,2±2,7  | 73,1±2,7  |
|                             | II – Контрольная | 67,7±2,8  | 65,1±2,6  |
| Умеренно-дифференцированная | I- Основная      | 90,6±1,9  | 89,7±1,8* |
|                             | II – Контрольная | 86,4±1,7  | 84,8±1,8  |
| Низко-дифференцированная    | I- Основная      | 83,8±2,2* | 82,1±2,1* |
|                             | II – Контрольная | 77,4±2,3  | 75,6±2,2  |

\*  $p < 0,05$  между группами исследования

Анализируя отдаленные результаты лечения больных раком тела матки с учетом возраста, особое внимание уделено выживаемости пациенток пременопаузального и менопаузального периодов жизни. По анализу результатов лечения больных раком тела матки с учетом возрастного периода, вне зависимости от методики лечения, наименьшая общая пятилетняя выживаемость отмечена у больных менопаузального возраста 71,7%. У женщин пременопаузального возраста пятилетние результаты достигли 78,3%. 5-летняя выживаемость больных раком эн-

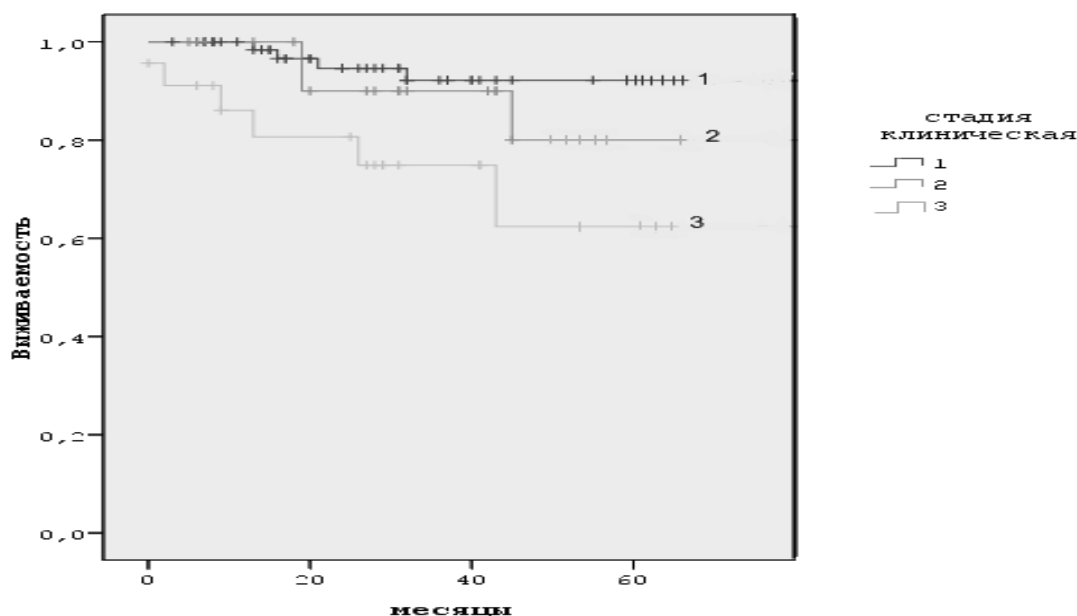


Рисунок 2 – Общая пятилетняя выживаемость в зависимости от стадии РТМ (Kaplan-Meier)

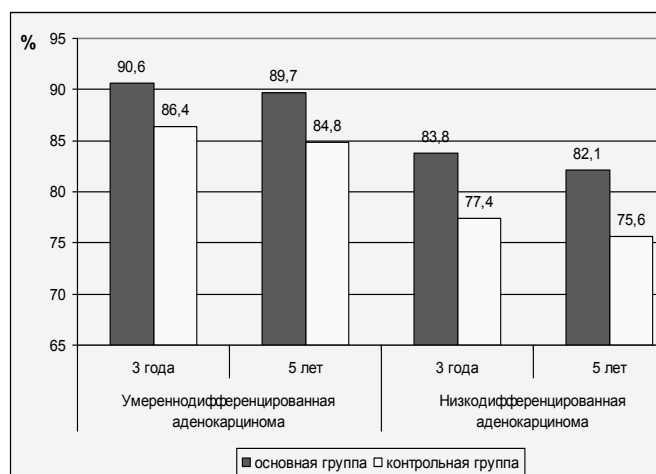


Рисунок 3- Выживаемость больных РТМ в зависимости от степени дифференцировки опухоли (умереннодифференцированная, низкодифференцированная) по видам лечения (%)

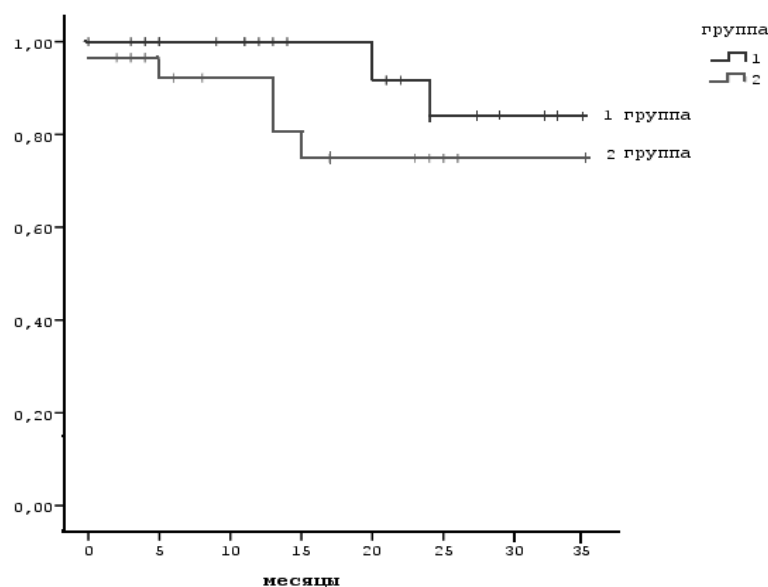


Рисунок 4 - Безрецидивная выживаемость больных раком тела матки основной и контрольной групп (Kaplan-Meier)

дометрия пременопаузального возраста при комплексном лечении была на 5,8% больше, чем при комбинированной терапии. В менопаузальном возрасте общая 5-летняя выживаемость составила 77,4% при комплексном лечении больных РТМ, пациентки дожили до 5-летнего срока наблюдения при комбинированном лечении в 66,0% случаях (рисунок 1). Показатели 5-летней выживаемости у пациенток репродуктивного периода составили 100%, как в основной, так и в контрольной группе.

Рассматривая 5-летнюю выживаемость с учетом стадии болезни, можно отметить, что данный признак оказывает влияние на отдаленные результаты лечения и является одним из факторов прогноза. Так при сравнении выживаемости больных с первой стадией (94,6%) с другими определяется достоверная разница по сравнению с пациентками,

имевшими вторую (85,3%) и третью (69,1%) стадии (рисунок 2).

При сопоставлении аналогичных данных между собой по 3-летней выживаемости отмечается общая тенденция улучшения результатов лечения при комплексной терапии больных РТМ. При рассмотрении отдаленных результатов лечения групп при комплексном и комбинированном лечении в зависимости от стадии злокачественного процесса отмечено, что данный показатель достоверно выше у больных основной группы при II стадии 89,8% против 80,7% в контрольной соответственно. При I и III стадиях разница в выживаемости была 95,9% против 93,8% и 73,1% против 65,1% в основной и контрольной группах соответственно.

При оценке отдаленных результатов лечения больных РТМ с учетом степени дифференцировки опухоли необходимо отметить, что более высокая 5-летняя выживаемость имела место у больных с умереннодифференцированной эндометриоидной аденокарциномой эндометрия (87,7%).

Проведение комплексной терапии при умереннодифференцированных аденокарциномах позволяло достичь 89,7% пятилетней выживаемости против 84,8% при проведении комбинированного лечения. Снижение показателей выживаемости наблюдалось у больных с низкодифференцированной формой, пятилетние результаты при комплексном и комбинированном методе лечения составили 82,1% и 75,6% соответственно. Подобное соотношение было и в показателях результатов 3-летней выживаемости больных РТМ (рисунок 3).

Следует остановиться на безрецидивном периоде выживаемости больных раком тела матки. Показатель безрецидивной выживаемости также был выше в группе комплексного лечения больных 80,2±1,3% против 75,2±1,8% при комбинированном лечении ( $p < 0,05$ ) (рисунок 4).

Безрецидивная трехлетняя выживаемость определена в группе больных менопаузального возраста и установлена 93,8±2,0% и 72,7±1,9% в основной и контрольной (комбинированное лечение) группах соответственно.

Отдаленные результаты при применении системной

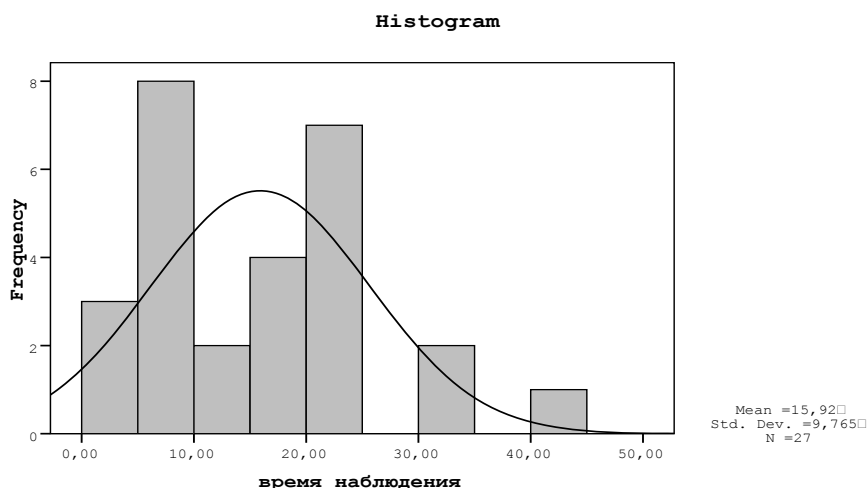


Рисунок 5 – Сроки наблюдения за больными, получившими системные курсы неoadъювантной полихимиотерапии в плане комплексного лечения

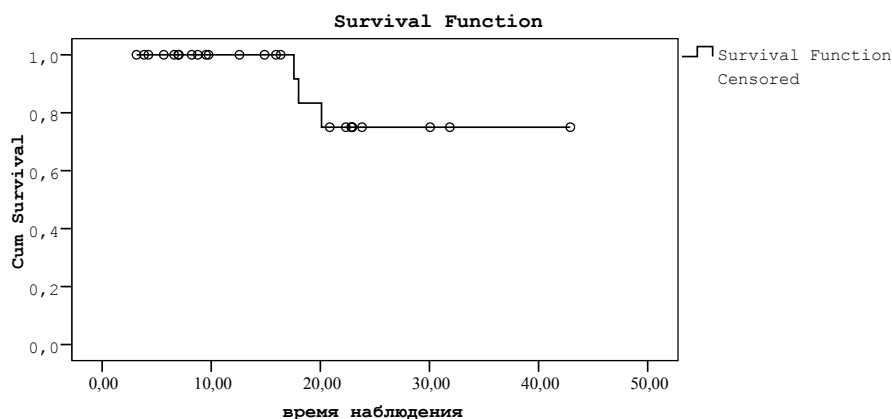


Рисунок 6 - Общая выживаемость больных после комплексного лечения с неoadъювантной внутривенной химиотерапией (Kaplan-Meier)

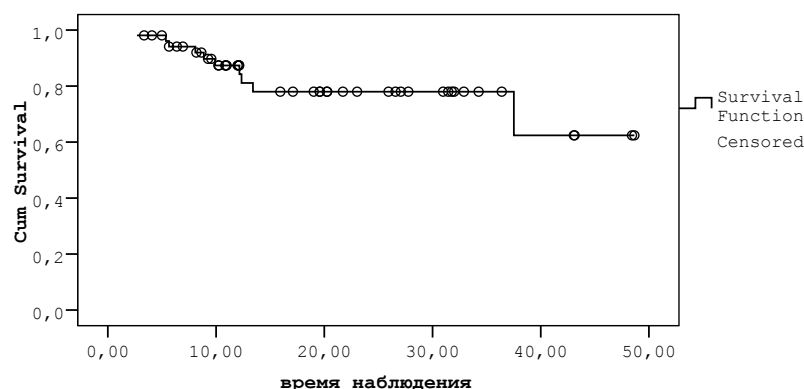


Рисунок 7 - Кумулятивная выживаемость больных местнораспространенным РШМ после сочетанной лучевой терапии (Kaplan-Meier)

полихимиотерапии у больных раком шейки матки Среднее время наблюдения за больными, лечение которых начато с проведения неoadъювантных курсов системной неoadъювантной полихимиотерапии составило  $15,92 \pm 1,88$  месяца (медиана 15,93 месяца) с минимальным сроком 3,15 месяца и максимумом 42,91 месяца (рисунок 5).

Как видно из представленного рисунка 5, срок наблюдения за большинством пациенток был в пределах 25 месяцев, меньшее количество больных прослежено 30 и 40 месяцев, фактическая выживаемость оценена в сроке наблюдения 42 месяца. Результаты терапии оценены у всех пролеченных больных этой группы.

На первом году наблюдения не умерла ни одна больная, от прогрессирования основного заболевания умерло по 1 больной на 17, 18 и 20 месяце наблюдения. С рецидивом заболевания на сегодняшний день живы 2 больных.

Из рисунка 6 видно, что 1-летняя выживаемость составляет 100%, при этом данный показатель сохраняется до 1,5 лет наблюдения. К середине второго года показатель выживаемости снижается до  $91,7 \pm 8,0\%$ . К концу двух лет живы  $83,3 \pm 10,8\%$  больных. А общая 4-х и 5-летняя выживаемость равна  $75,0 \pm 12,5\%$ .

Показатель 5-летней безрецидивной выживаемости у больных, получивших системную неoadъювантную химиотерапию, составил  $66,7 \pm 7,2\%$ .

Установлено, что относительный риск смерти после проведения системной неoadъювантной полихимиотерапии имеет пик в сроке 18 - 20 месяцев, составляя 0,7, и снижается в последующем до минимальных значений.

Основной целью неoadъювантной химиотерапии является уменьшение первичной опухоли и ее метастазов

для создания лучших условий для проведения в дальнейшем радикального хирургического лечения.

В исследуемой группе больных, через 3 недели после завершения неoadъювантной полихимиотерапии радикальное хирургическое лечение удалось выполнить в 17 случаях, что составило 62,9%.

При анализе результатов лечения оказалось, что показатель кумулятивной выживаемости выше в тех случаях, когда больным после проведения системной неoadъювантной полихимиотерапии удалось выполнить радикальное хирургическое лечение. Так, у

оперированных больных показатель общей 5-летней выживаемости составил  $80,0 \pm 7,9\%$ , а у пациенток, которые не были оперированы, общая 5-летняя выживаемость оказалась равной  $71,4 \pm 7,1\%$ , разница не достоверна ( $p > 0,05$ ).

Традиционно сочетанная лучевая терапия является основным и общепринятым методом лечения местнораспространенного РШМ. Отдаленные результаты сочетанной лучевой терапии, проведенной по радикальной программе, оценены у 53 пациенток. Максимальный срок наблюдения составил 48,6, минимальный – 2,7 месяцев (рисунок 7).

Из рисунка 7 видно, что кривая выживаемости имеет резкое падение к концу первого года наблюдения. При этом на первом году показатель общей выживаемости у больных местнораспространенным РШМ, получивших сочетанную лучевую терапию составил 78,0%. В оставшийся промежуток времени отмечается дальнейшее падение кривой выживаемости на отметке 36 месяцев. Общая пятилетняя выживаемость после сочетанной лучевой терапии, рассчитанная с помощью модели пропорционального риска Кокса, составила  $64,0 \pm 7,0\%$ . Три года без признаков заболевания живы  $53,0 \pm 2,4\%$ , а показатель 5-летней безрецидивной выживаемости равен  $46,6 \pm 2,4\%$ .

Таким образом, проведение комплексной терапии при раке тела и шейки матки с применением неoadъювантной полихимиотерапии показало перспективность метода лечения.

НПХТ у больных раком тела матки увеличивает как общую ( $86,9\%$ ), так и безрецидивную выживаемость больных ( $70,2\%$ ) против  $80,2\%$  и  $56,2\%$  соответственно при комбинированном лечении. Проведение комплексной терапии при РТМ имело более выраженный эффект на отдаленные результаты при II стадии заболевания.

НПХТ увеличивает общую 5-летнюю выживаемость больных местнораспространенным раком шейки матки, получивших в составе комплексного лечения неoadъювантные курсы системной полихимиотерапии и равна  $75,0 \pm 12,5\%$ , 5-летняя безрецидивная выживаемость составила  $66,7 \pm 27,2\%$ . Процент резектабельности РШМ после проведения неoadъювантной химиотерапии составил 62,9%.

## Список литературы

1. Мерабишвили В.М. Лалианци Э.И., Чепик О.Ф., Субботина О.Ю. Рак тела матки: динамика заболеваемости, смертности и выживаемости больных. // *Вопр. онкол.* - 2012. - Т.58, № 3. - С.339-345.
2. Мерабишвили В.М. Лалианци Э.И., Чепик О.Ф., Субботина О.Ю. Динамика наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком шейки матки (популяционное исследование) // *Вопр. онкол.* - 2012. - Т.58, № 3. - С. 333-338.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2007 год. - Алматы, 2007. - 101 с.
4. Waggoner S. Cervical cancer // *Lancet.* - 2003. - Vol 361. - P.2217-2225.
5. Fleming G. Adjuvant Therapy for High-risk Adenocarcinoma of the Uterus // *ASCO*, 2008. - P 230-233.
6. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - М.: Медицина, 1989. - 463с.
7. Манжура Е.П., Вакуленко Г.А., Мицкевич В.Е. и соавт. Патогенетическое обоснование лечения агрессивных форм рака эндометрия // *Матер. V съезда онкологов и радиологов СНГ.* - Ташкент, 2008. - С. 391.

### Тұжырым

Ж.К.Чингисова, М.Р.Кайрбаев, Е.К.Кукубасов, Р.Ш.Шалбаева, Ж.Досаханов

Неоадьювантты полихимиотерапияны қолданудағы жатыр мойын мен жатыр денесінің қатерлі ісігі бар науқастардың өміршендігі.

Бұл жұмыс жатыр денесі қатерлі ісігі және жатыр мойны қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың адьювантты емес полихимиотерапияны қолдану арқылы комплексті ем алған науқастардың өмір сүру ұзақтығын зерттеуге негізделген. Жатыр мойны денесінің қатерлі ісігінде адьювантты емес полихимиотерапияны қолдану,

құрама емнің нәтижелеріне (80,2% және 56,2%) қарағанда жалпы өмір сүру ұзақтығын (86,9%) және рецидивсіз кезеңді (70,0%) жоғарылатты. Жатыр мойны қатерлі ісігінде жалпы 5 жылдық өмір сүру ұзақтығы 75,0% рецидивсіз кезең 66,7% құрады, ал жергілікті таралған жатыр мойны қатерлі емдеудегі негізгі және жалпылама қабылданған әдіс болып табылатын үйлесімді сәулемен емдеуден кейінгі көрсеткіштер 64,0% және 46,6% болды.

Түйінді сөздер жатыр мойнының қатерлі ісігі, жатыр денесінің қатерлі ісігі, неоадьювантты полихимиотерапия.

### Summary

Chingissova Zh.K., Kayrbaev M.R., Kukubasov E.K, Shalbaeva R.Sh., Dossakhanov Zh.A.

Survival of patients with uterus and cervix cancer using neoadjuvant chemotherapy

Current work is based on survival analyses of patients with endometrial and cervical cancer who underwent neoadjuvant chemotherapy (NACT). NACT resulted in increased indexes of overall survival (86.9%) and disease free survival (70%) in endometrial cancer patients compared to 80.2% and 56.2% accordingly. In cervical cancer NACT resulted in 75% overall survival and 66.7% disease free survival. After radiation therapy which is a standard treatment of such patients overall and disease free survival of patients with locally advanced cervical cancer were 64.0% and 46.6% accordingly.

Keywords: cervical cancer, uterine cancer, neoadjuvant chemotherapy, the survival rate